Douleur : échelles, évaluation et suivi

UE B.3 · Domaine B · CM du 22/10/2026, 8 h 30–10 h 30 (planning de promotion).
VERSION PROVISOIRE — synthèse de travail à confronter au CM de Mme Tison.

Objectifs : Décrire la douleur avec les mots de la personne et rechercher son retentissement. · Choisir une échelle adaptée aux capacités de communication et garder le même outil pour comparer. · Réévaluer, tracer et transmettre l'efficacité et la tolérance des actions réalisées.

Cours détaillé

- Douleur = expérience personnelle sensorielle et émotionnelle : croire la personne et chercher le retentissement.
- Recueil structuré : localisation/irradiation, début, durée, type, intensité, facteurs, retentissement, traitements déjà reçus.
- Auto-évaluation prioritaire si possible; sinon échelle d'observation validée adaptée à l'âge et au contexte.
- Après soin ou antalgique : réévaluer au délai adapté, surveiller l'effet et les effets indésirables, tracer et transmettre.

1. Repérer et caractériser

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle personnelle, influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. La parole de la personne est la référence quand elle peut s'exprimer. Une absence de plainte, un sourire ou une apparente tranquillité ne suffisent pas à conclure à une absence de douleur.

Recueillir de façon reproductible : localisation et irradiation; début, durée, rythme et évolution; type de sensation (brûlure, élancement, décharge, crampe); intensité; facteurs qui aggravent ou soulagent; retentissement sur sommeil, mobilité, humeur, appétit et activités; traitements/mesures déjà essayés et effet observé.

Préciser le contexte du score : au repos, au mouvement, lors d'un transfert, d'une mobilisation ou d'un soin. Une douleur provoquée par un soin se prévoit autant que possible : expliquer, installer, évaluer avant le geste, appliquer les mesures prévues, puis réévaluer.

Repères : la douleur aiguë accompagne souvent une atteinte récente et peut avoir une fonction d'alarme; la douleur chronique persiste ou récidive au-delà de trois mois selon la définition HAS. Une douleur peut être nociceptive (inflammation/lésion), neuropathique (atteinte du système nerveux : brûlures, décharges, fourmillements) ou mixte. Le type ne se déduit pas du score seul.

La douleur totale comporte aussi des dimensions émotionnelles, sociales et parfois spirituelles. Écouter, respecter le vocabulaire choisi par la personne, rechercher ses priorités et intégrer son entourage avec son accord aide à individualiser le projet de soins.

Mécanismes utiles à distinguer : une douleur nociceptive survient lorsqu'une lésion ou une inflammation active les récepteurs de la douleur. Elle peut être somatique (peau, muscles, articulations; souvent mieux localisée) ou viscérale (organe; parfois diffuse ou projetée). Une douleur neuropathique est liée à une atteinte du système somatosensoriel; brûlure, décharge électrique, fourmillement, engourdissement ou douleur au simple contact sont des descriptions à explorer,

sans poser de diagnostic sur le seul vocabulaire. Plusieurs mécanismes peuvent coexister, par exemple après une chirurgie.

Trame de recueil : où se situe la douleur, irradie-t-elle? Quand a-t-elle commencé, combien de temps dure-t-elle, est-elle continue ou par crises? Comment la personne la décrit-elle? Quelle intensité donne-t-elle avec l'outil retenu? Qu'est-ce qui l'aggrave ou la soulage? Quel retentissement sur le sommeil, la mobilité, l'humeur, l'appétit, les soins et les activités? Quel objectif est le plus important pour elle? Compléter par les traitements déjà reçus, l'horaire et l'effet observé, sans suggérer de réponse.

Distinguer douleur au repos, douleur à l'activité, douleur provoquée par un soin et épisodes de douleur aiguë sur un fond chronique. Le contexte change le score : une mesure au repos ne répond pas à la même question qu'une mesure pendant un transfert. Pour suivre une tendance, noter les conditions de mesure, utiliser si possible le même outil et comparer des situations proches. Une cartographie corporelle peut aider la personne à montrer une zone lorsque les mots manquent.

2. Choisir l'outil

Auto-évaluation : proposer d'abord une échelle comprise par la personne. EN : choisir un nombre entre 0 (aucune douleur) et 10 (douleur maximale imaginable). EVA : placer un curseur sur une ligne graduée; s'assurer que la personne voit et comprend l'outil. EVS : choisir un qualificatif verbal. Présenter les consignes de façon neutre, sans suggérer la réponse.

Hétéro-évaluation : si la personne ne peut pas s'auto-évaluer, choisir une échelle validée et adaptée au contexte, avec l'équipe. ALGOPLUS concerne la douleur aiguë de la personne âgée ayant des troubles de communication; DOLOPLUS-2 explore la douleur chronique chez la personne âgée non communicante. Observer plusieurs signes et comparer au comportement habituel.

Chez l'enfant, tenir compte de l'âge, du développement et de la capacité à comprendre; utiliser l'échelle pédiatrique validée du service. En réanimation, sédation ou troubles cognitifs, suivre l'outil et la procédure de l'unité. Réessayer l'auto-évaluation si les capacités changent.

Ne pas remplacer une évaluation par un seul signe (fréquence cardiaque, agitation, grimace). Un signe isolé n'est pas spécifique. Ne pas convertir ni comparer directement deux scores issus d'échelles différentes; garder le même outil et le même contexte autant que possible.

Avant de retenir une échelle, vérifier que la personne comprend la consigne, voit ou entend le support et peut répondre à cet instant. Reformuler simplement, laisser du temps et éviter les questions orientées. La capacité d'auto-évaluation peut varier avec la fatigue, la vigilance ou l'anxiété; réessayer si son état change. Une échelle mesure un aspect précis, pas toute l'expérience douloureuse.

Pour une hétéro-évaluation, décrire des comportements observables (« repousse la main au retrait du pansement ») plutôt qu'une interprétation (« opposant »). Comparer à l'état habituel et rechercher d'autres explications d'un comportement nouveau : inconfort, dyspnée, confusion, peur ou besoin d'élimination. Les proches peuvent aider à connaître le comportement habituel, sans remplacer l'outil choisi avec l'équipe.

Un score élevé, une modification brutale, une douleur qui ne répond pas comme prévu ou un retentissement majeur justifient une réévaluation et une transmission. Un score bas n'annule ni la demande de la personne ni un signe d'alerte. Ne pas calculer de moyenne ni convertir directement des scores issus d'échelles différentes.

3. Agir, réévaluer, tracer

Le rôle infirmier comprend l'écoute, l'évaluation, la prévention des douleurs provoquées, les mesures non médicamenteuses adaptées et prescrites/protocolisées, l'administration des traitements dans le cadre prévu, la surveillance, la traçabilité et l'alerte. Installer confortablement, expliquer le soin, préserver le contrôle de la personne et proposer une pause si le plan de soins le permet.

Après une action, réévaluer au délai adapté à la voie, au produit et au protocole local; il n'existe pas un délai unique pour toutes les situations. Comparer avec le score initial dans un contexte semblable. Demander à la personne si le soulagement lui convient et si la fonction (sommeil, transfert, soin) s'améliore.

Surveiller l’efficacité et la tolérance du traitement prescrit selon le médicament et le patient : vigilance/somnolence, respiration si opioïde ou sédatif, nausées, constipation, prurit, rétention urinaire ou autres effets attendus. Appliquer les paramètres d’alerte et fréquences de surveillance du protocole; ne pas modifier seul une prescription.

Si douleur importante persistante, nouvelle, inhabituelle ou rapidement croissante, si le score ne baisse pas comme attendu, ou si un effet indésirable apparaît : réévaluer, sécuriser, prévenir le professionnel responsable/prescripteur selon le degré d’urgence, puis tracer la réponse.

Tracer : date/heure, situation et retentissement, outil/score, mesure réalisée et heure, résultat de la réévaluation, tolérance, information/alerte et prochaine étape. Transmettre un changement clinique clairement, avec faits et chronologie.

Les mesures non médicamenteuses se choisissent selon la cause, les préférences et les contre-indications : installation et soutien d’un membre, explication et contrôle partagé du rythme du soin, réduction des stimulations, respiration guidée, distraction ou relaxation. Elles complètent les traitements et ne retardent pas l’évaluation d’une urgence. Froid, chaleur, massage ou mobilisation ne sont pas universels : vérifier sensibilité, perfusion, état cutané, indication et protocole.

Pour un antalgique, vérifier prescription, identité, allergies, dose, voie, horaire, dernières prises et surveillance attendue. Les risques varient selon la molécule et la personne : certains opioïdes imposent une vigilance sur la somnolence et la respiration; les anti-inflammatoires ont des précautions digestives, rénales ou hémorragiques. Ces exemples ne remplacent ni les connaissances pharmacologiques, ni la notice, ni la prescription. Ne pas modifier le traitement de sa propre initiative.

Réévaluer l’intensité, le bénéfice fonctionnel recherché, le délai d’action attendu et la tolérance. Si le soulagement est insuffisant, si la douleur revient avant l’heure prévue ou si un effet indésirable apparaît, transmettre à l’IDE responsable ou au prescripteur. En cas de détresse respiratoire, altération importante de la conscience, douleur thoracique brutale ou autre signe de gravité, déclencher immédiatement la procédure d’urgence locale.

Rôle infirmier, surveillance et alerte

- Écouter sans minimiser; rechercher la localisation, l’histoire, le retentissement et les attentes de la personne.
- Anticiper le soin douloureux; choisir avec l’équipe un outil adapté et conserver une méthode comparable.
- Réaliser les actions relevant du rôle propre, appliquer prescription/protocole, surveiller efficacité et tolérance, tracer et transmettre.

Mini-situation : une personne évalue sa douleur à EN 7/10 pendant un transfert. Tu vérifies ce qui l’aggrave, installes et informes, appliques le plan antalgique prescrit avant le soin si prévu, puis réévalues au délai prévu. Si la douleur reste gênante, tu transmets le score, le contexte, l’action et l’effet; tu ne modifies pas seul la prescription.

Situations cliniques guidées

Appliquer les repères du cours : recueillir les données, analyser, agir dans son champ de compétence et réévaluer.

Cas 1 — douleur postopératoire au mouvement

Situation : Mme L., 68 ans, est opérée le matin. Au repos, elle dit « ça va à peu près », mais se crispe et retient sa respiration au lever. Elle cote sa douleur EN 3/10 au repos et 7/10 pendant le transfert. Elle craint de tousser et de marcher.

Raisonnement : le score dépend du contexte; les deux scores répondent à deux questions différentes. Demander où elle a mal, quel type de sensation, depuis quand, ce qui la soulage et ce qui l'empêche de faire. Vérifier le plan prescrit et l'heure de la dernière dose; ne pas conclure à l'absence de douleur au repos ni confondre grimace et mesure.

Actions et surveillance : expliquer chaque étape, installer et accompagner le mouvement, proposer les mesures de confort autorisées et appliquer le traitement prévu dans le cadre prescrit. Réévaluer au délai prévu avec la même échelle, au repos et lors d'un mouvement comparable. Surveiller l'effet attendu et les effets liés au produit, notamment vigilance et respiration si le traitement le justifie. Si douleur persistante ou effet indésirable, prévenir l'IDE responsable/prescripteur selon l'urgence.

Exemple de transmission : « 9 h 10, EN 3/10 au repos, 7/10 au transfert; douleur localisée à la zone opératoire, limite la mobilisation. Mesure prévue au protocole réalisée à 9 h 15; réévaluation à l'heure prévue : EN 4/10 au transfert, patiente dit mieux tolérer le lever. Surveillance et suite transmises. » Adapter le délai, les éléments transmis et le traitement à la situation réelle.

Cas 2 — personne âgée qui communique peu

Situation : M. R., 84 ans, présente des troubles cognitifs et répond peu aux questions. Pendant la toilette, il repousse la main, fronce le visage et gémit; au repos il est calme. Ces comportements sont nouveaux selon l'aide-soignante.

Raisonnement : rechercher d'abord les capacités du moment et essayer une question simple ou une auto-évaluation adaptée, sans insister si elle n'est pas comprise. Si elle est impossible, choisir avec l'équipe une échelle d'hétéro-évaluation validée pour l'âge et le contexte; comparer à son comportement habituel. Une agitation peut avoir plusieurs causes; l'échelle guide l'observation, elle ne détermine pas seule l'origine.

Actions : interrompre ou adapter le geste si possible, préserver le confort et la dignité, examiner les circonstances, puis appliquer le plan de soins. Relever le score avant/après selon l'outil retenu, documenter les signes observés et l'effet, transmettre le changement nouveau et rechercher une cause clinique avec l'équipe.

Cas 3 — douleur thoracique nouvelle : ne pas banaliser

Situation : pendant une activité, M. D., 59 ans, signale une douleur thoracique inhabituelle, apparue brutalement. Il devient pâle et essoufflé; il cote la douleur à 8/10. Il demande un antalgique qu'il prend habituellement.

Priorité clinique : ne pas traiter cette plainte comme une douleur habituelle avant d'avoir évalué l'urgence. Interrompre l'activité, rester auprès de la personne, appeler immédiatement l'IDE responsable/équipe d'urgence selon le lieu, évaluer rapidement les fonctions vitales selon le niveau de formation et le protocole (ABCDE si appris et applicable), recueillir l'heure de début et les symptômes associés. Ne pas laisser la personne seule ni la faire marcher pour rejoindre un lieu de soins.

Ce qu'il faut transmettre : début brutal, localisation et description avec ses mots, score et échelle, signes observés, constantes si la procédure et la compétence le permettent, antécédents ou traitement rapporté, actions déjà faites et évolution. Administrer un médicament uniquement selon une prescription/protocole applicable et les consignes de l'équipe d'urgence; ne pas retarder l'alerte pour compléter une évaluation longue.

Point d'apprentissage : mesurer la douleur est nécessaire, mais le score ne détermine pas à lui seul la cause ni le degré d'urgence. Une douleur nouvelle avec signes associés impose une évaluation clinique et une alerte adaptées.

Cas 4 — douleur chronique et objectif fonctionnel

Situation : Mme S. vit avec une douleur lombaire depuis plusieurs mois. Elle cote EN 5/10 aujourd'hui, identique à la semaine précédente, mais dit avoir pu dormir et s'habiller avec moins d'aide. Elle souhaite participer à une activité qu'elle évite habituellement.

Raisonnement : ne pas réduire le suivi au chiffre. Reprendre le même outil et préciser le contexte, comparer la tendance avec les évaluations antérieures, puis explorer les objectifs importants pour elle : sommeil, mobilité, autonomie, participation et effets indésirables. Une douleur chronique peut persister malgré une amélioration fonctionnelle; l'objectif est construit avec la personne et l'équipe.

Rôle infirmier : reconnaître l'expérience exprimée sans attribuer automatiquement une aggravation à un comportement; soutenir l'autonomie et les stratégies non médicamenteuses convenues, encourager un rythme d'activité adapté au plan, surveiller la tolérance des traitements prescrits et transmettre l'évolution fonctionnelle. Éviter de proposer une modification thérapeutique autonome ou de comparer son score à celui d'un autre patient.

À retenir : noter à la fois l'intensité, le contexte, l'effet sur la vie quotidienne et la priorité exprimée par la personne. Un score stable ne signifie pas que la prise en charge est inutile; il faut analyser la trajectoire et la réponse selon plusieurs dimensions.

Ex. EN 7/10 au transfert → écouter et préciser le contexte → appliquer le plan prescrit → réévaluer au délai prévu → tracer l'effet et alerter si besoin.

Repères pratiques

Situation	Repère d'outil
Adulte communicant	EN, EVA ou EVS selon compréhension et capacités
Douleur aiguë, personne âgée non communicante	ALGOPLUS; observer selon la grille et le contexte
Douleur chronique, personne âgée non communicante	DOLOPLUS-2; apprécier aussi les changements de comportement
Enfant / patient sédaté	Échelle pédiatrique ou observationnelle validée du service
Comparaison avant/après	Même outil, contexte comparable, délai défini par protocole

À retenir

• La douleur est subjective : écouter et croire le récit de la personne.

- Auto-évaluation prioritaire si possible; sinon outil d'observation validé, jamais un signe isolé.
- EN/EVA/EVS ne sont pas interchangeables : conserver le même outil pour suivre.
- Évaluer au repos et pendant l'activité/le soin lorsque cela répond à la question clinique.
- Anticiper les douleurs provoquées; réévaluer au délai adapté à la mesure ou au traitement.
- Surveiller efficacité, tolérance et retentissement; tracer l'heure et l'évolution.
- Ne pas modifier une prescription; alerter si douleur persistante, nouvelle ou aggravée.

Lexique

Allodynie	Douleur déclenchée par un stimulus normalement non douloureux.
Analgésie	Diminution ou suppression de la douleur.
Douleur neuropathique	Douleur liée à une lésion ou maladie du système somatosensoriel; sensations possibles de brûlure ou décharge.
Douleur nociceptive	Douleur liée à l'activation des nocicepteurs lors d'une atteinte tissulaire.
EN	Échelle numérique : chiffre choisi par la personne, généralement de 0 à 10.
EVA	Échelle visuelle analogique : curseur ou repère positionné sur une ligne graduée.
EVS	Échelle verbale simple : choix parmi des qualificatifs d'intensité.
Hétéro-évaluation	Évaluation par observation quand l'auto-évaluation est impossible.
Hyperalgésie	Réponse douloureuse exagérée à un stimulus douloureux.
Retentissement	Conséquences de la douleur sur les fonctions, activités, sommeil ou humeur.

Sources : cours externe · référentiel 2026 · source officielle complémentaire. À comparer au CM de Mme Tison.

Schéma explicatif de fin de cours

Repères visuels pour relier l’observation, le raisonnement et les actions infirmières.



Si la personne ne peut pas s’auto-évaluer : outil d’observation validé, signes concrets et comparaison au comportement habituel.

Le score ne remplace ni le récit, ni l’examen clinique, ni l’alerte devant un signe de gravité.